

Dispercepire il Mondo

Salute Mentale · Sessione 05 · 18.03.2026

Questa lezione apre un nuovo blocco del modulo: capire come "funziona" la mente quando qualcosa non va. Prima di parlare di diagnosi, dobbiamo imparare a leggere i segni. È un po' come imparare a leggere le tracce in un bosco prima di sapere che animale le ha lasciate. Tre grandi temi: semiologia (lettura dei segni), funzioni cognitive e psicofarmacologia.

1. Semiologia: leggere i segni della mente

La **semiologia** è la disciplina che studia i segni rilevabili in una persona per capire come sta. In psichiatria significa osservare, raccogliere dati, e costruire un quadro clinico. È il linguaggio comune su cui si basano tutte le lezioni successive.

Due concetti fondamentali da non confondere mai — li chiedono all'esame:

- **Segni** → indicatori di malattia **oggettivamente riscontrabili** dal curante (es. febbre, tremore, frequenza cardiaca)
- **Sintomi** → indicatori di malattia **riferiti dal paziente** (es. mal di testa, dolore, sensazione di angoscia)

La semiologia si articola in due grandi aree: la **semiologia del comportamento** e la **semiologia dello stato mentale attuale**.

2. Semiologia del Comportamento

Riguarda tutto quello che possiamo osservare nel modo in cui una persona si presenta nel contesto. Già dal primo momento in cui qualcuno entra in uno spazio possiamo raccogliere informazioni preziose.

2.1 Apparenza e mimica

Come si presenta la persona? Come cura il proprio corpo e il proprio abbigliamento? **La prof racconta di una paziente con depressione grave: quando stava bene arrivava curata e truccata, quando il tono dell'umore calava arrivava con i capelli sporchi e l'abbigliamento trascurato. Non era mancanza di rispetto — era il malessere che parlava.**

Sul fronte della mimica facciale: - **Ipertimia** → mimica molto accentuata, espressiva (tipica nelle fasi maniacali) - **Amimia** → mimica ridotta, povera (tipica nella depressione o nel Parkinson) - **Mimica discordante** → l'espressione facciale non corrisponde all'emozione vissuta (può comparire nella schizofrenia)

Un esempio clinico: un paziente con problemi di alcolismo arriva al primo colloquio semi-volontariamente, spinto dal medico. Entra, stringe la mano alla terapeuta, poi prende la sedia e la sposta dall'altra parte della stanza, vicino alla porta. Cosa sta comunicando? Paura, bisogno di via di fuga, sfiducia. La terapeuta lo lascia fare e conduce tutti i colloqui rispettando quella disposizione, finché la relazione di fiducia non si è costruita abbastanza.

2.2 Il discorso

Non conta solo il contenuto di quello che dice una persona, ma anche *come* lo dice: - **Velocità: una persona in stato d'ansia spesso parla velocissima** - **Tono: una persona con umore deflesso parla sottovoce, lentamente** - **Fluire del discorso: va stimolato o arriva spontaneamente?**

2.3 Comportamento e condotte istintuali

- **Cura del sé:** sonno, alimentazione, igiene, relazioni sociali
- **Disturbi del sonno:** risvegli precoci mattutini (tipici in alcuni disturbi dell'umore) o difficoltà ad addormentarsi (tipiche nei disturbi ansiosi, per il rimuginio)
- **Disturbi alimentari e sessuali:** temi delicati che emergono spesso in ritardo, a volte legati agli effetti collaterali dei farmaci. Importante non

escluderli dalla tematizzazione — possono compromettere la compliance alla terapia

- **Disturbi sfinterici:** nelle demenze, prima incontinenza urinaria poi fecale. Causano grande vergogna, spesso non vengono riferiti spontaneamente
- **Qualità delle relazioni sociali e familiari:** la persona ha una rete di supporto o si è isolata progressivamente?

2.4 Passaggi all'atto

Si intendono comportamenti: - **Auto-aggressivi** (es. tagliarsi, automutilazione) - **Etero-aggressivi** (aggressioni verso altri) - **Fughe dissociative:** allontanamento improvviso dal contesto, spesso conseguente a un trauma. La persona sembra orientata ma è disorientata, e può non ricordare niente di ciò che è accaduto. Da distinguere dagli **allontanamenti nelle demenze** (Alzheimer): nel secondo caso c'è una degenerazione cognitiva che impedisce di ritrovare la strada — non è una fuga dissociativa

Rientrano qui anche comportamenti legati a **disturbi del controllo degli impulsi:** **piromania** (la persona sa che è sbagliato ma non riesce a fermarsi), **cleptomania**, aggressioni di tipo sessuale.

2.5 Disturbi delle funzioni psicomotorie

- **Agitazione psicomotoria:** frequente nelle forme ansiose
 - **Catatonìa:** perdita di iniziativa motoria con aumento del tono muscolare. La persona rimane nella posizione in cui viene posta. **Attenzione:** possono comparire movimenti bruschi improvvisi
 - **Tic:** movimenti rapidi involontari, solitamente al volto
 - **Paracinesi:** movimenti che alterano il movimento normale (es. il paziente cammina e intanto muove il braccio come per scacciare insetti — fuori contesto)
 - **Stereotipie:** sequenze comportamentali ripetute in determinati momenti (es. dondolamento nell'autismo, picchietto sul tavolo nelle demenze). Apparentemente senza funzione, ma spesso tranquillizzanti per il paziente
-

3. Semiologia dello Stato Mentale Attuale

Questa area indaga le **funzioni mentali** in senso più profondo: come funzionano, come interagiscono tra loro, e cosa succede quando una si altera. Il termine "attuale" è fondamentale: si valuta il momento presente.

3.1 Coscienza

A livello clinico, la persona è cosciente quando: sa chi è, sa dove si trova, è in grado di reagire all'ambiente. La coscienza si articola su tre assi: - Asse della **vigilanza** (vigilanza ↔ sonnolenza) - Asse della **lucidità** (lucidità ↔ ottundimento) - Asse della **coscienza di sé**

Alterazioni quantitative (scala progressiva): **lucidità** → **ottundimento** → **torpore** → **sopore** → **coma**

Il torpore è già clinicamente rilevante: il paziente è cosciente ma se non viene stimolato perde i sensi. Esempio pratico dato in lezione: un ragazzo che ha bevuto troppo — se non si sa quanto ha bevuto e lo si manda a dormire, l'alcolemia potrebbe continuare a salire progressivamente. Vigilare è fondamentale.

Alterazioni qualitative della coscienza: - **Stato confusionale/delirium** → alterazione dell'attenzione e della coscienza (si può trovare nell'alcolismo cronico) - **Mania à potu** → stato di mania scatenato anche da bassi quantitativi di alcol, in persone che dopo anni di abuso hanno sviluppato una forma di intolleranza.

Diverso dal **delirium tremens** (che è una sindrome da astinenza) - **Stato crepuscolare** → in alcune forme di epilessia o psicosi - **Stato oniroide** → come in un sogno, perdita di contatto con la realtà, possibili allucinazioni visive - **Automatismo** → la persona ripete gesti abituali fuori contesto (es. mima il lavaggio dei piatti mentre è in salotto) - **Stupore** → legato alla catatonìa, perdita di intenzionalità - **Fenomeni dissociativi** → connessi alle fughe dissociative

3.2 Orientamento

Capacità di sapere chi si è (persona), dove si è (spazio) e che momento è (tempo).
Nella cartella clinica si trova scritto: "*orientata/o nei tre domini*".

L'orientamento nel **tempo** è il più labile: può alterarsi anche per emozioni intense o grande concentrazione, senza che ci sia patologia. Quello nello **spazio** è già più significativo. Il disorientamento nella **persona** (non so chi sono) è il clinicamente più grave.

Se c'è disorientamento in spazio + tempo insieme, si deve iniziare a pensare a una problematica cerebrale. Se si aggiunge il disorientamento nella persona, la situazione è ancora più seria.

Riferimento cinematografico citato: *Still Alice* (film e libro) — una psicologa con Alzheimer precoce che si perde in casa propria, incapace di ritrovare il bagno.
Un'immagine potente di cosa significa perdere l'orientamento nello spazio.

3.3 Memoria

La memoria è strettamente legata all'identità. Non è una funzione unitaria: è un sistema articolato in componenti interconnesse.

Classificazione temporale:

Tipo	Durata	Caratteristiche
Memoria sensoriale	1-2 secondi	Registra le impressioni sensoriali. <i>Iconica</i> (visiva), <i>Ecoica</i> (uditiva)
Memoria a breve termine (MBT)	~20-30 sec	Capacità limitata: 5-9 elementi. Aumentabile raggruppando le info (chunking)
Memoria di lavoro	Variabile	Rielabora le info per compiti complessi. Rientra nelle funzioni esecutive
Memoria a lungo termine (MLT)	Illimitata	Si divide in esplicita e implicita

Per capire la differenza tra MBT e memoria di lavoro: **se la prof dice una serie di numeri e il paziente la ripete tale e quale → memoria a breve termine**. Se il paziente deve ripeterla al contrario → **memoria di lavoro (deve rielaborare l'informazione)**.

Memoria a lungo termine: - **Implicita/non dichiarativa** → automatismi appresi (lavarsi i denti, guidare). Diventano procedure inconscie - **Esplicita/dichiarativa** → si suddivide in: - **Episodica**: eventi della vita personale, ricordi flash emotivamente intensi (es. l'11 settembre) - **Semantica**: nozioni apprese (es. le definizioni che studiate per l'esame)

Disturbi quantitativi della memoria: - **Ipomnesia** → traccia mnestica ridotta - **Amnesia anterograda** → impossibilità di codificare nuove informazioni dopo un evento indice. **Esempio clinico: paziente con sindrome di Korsakoff che chiede ogni pochi minuti se può bere il succo d'arancia — non riesce a trattenere la risposta appena ricevuta** - **Amnesia retrograda** → impossibilità di recuperare informazioni già immagazzinate prima dell'evento indice. **Esempio citato: il libro -12 — un medico che si risveglia dal coma con un buco di memoria di 12 anni** - **Ipermnesia** → capacità aumentata di revocare ricordi (in stati allucinatori o con l'uso di alcune sostanze)

Disturbi qualitativi della memoria (paramnesie): - **Falsi ricordi** → la persona ricorda gli eventi in modo diverso da come si sono svolti (involontariamente) - **Confabulazioni** → falsificazioni involontarie della memoria in stato di lucidità (es. nella sindrome di Korsakoff: la persona costruisce risposte plausibili ma inventate, senza esserne consapevole) - **Déjà vu / déjà vécu** → sensazione di familiarità con eventi non vissuti. Non necessariamente patologico

3.4 Attenzione

L'attenzione è la capacità di indirizzare e focalizzare l'attività psichica su contenuti specifici.

Tre componenti principali:

1. **Attenzione selettiva** → concentrazione su un unico obiettivo ignorando il resto. **Dimostrata in lezione con un gioco di carte: chi si focalizzava sulle carte**

non notava 5 cambiamenti nel contesto. Nell'ansia: la persona è così focalizzata sul problema da non vedere le possibili soluzioni

2. **Attenzione divisa** → attenzione su più fonti contemporaneamente, a patto di usare schemi cognitivi diversi. Es: guardare immagini TV + parlare al telefono funziona; ascoltare voce TV + parlare al telefono crea interferenza (stesso canale cognitivo). Particolarmente sensibile all'invecchiamento — importante nella valutazione dell'idoneità alla guida
3. **Attenzione sostenuta** → capacità di mantenere l'attenzione a lungo in compiti monotoni.

3.5 Disturbi della percezione

La distinzione fondamentale: sensazione vs. percezione

- **Sensazione** → attivazione degli organi di senso a opera di una sorgente di energia fisica. È il dato grezzo
- **Percezione** → organizzazione, interpretazione, analisi e integrazione degli stimoli da parte del cervello. È sempre una ricostruzione soggettiva basata sull'esperienza

Distorsioni quantitative: - **Iperestesia** → amplificazione. Es: durante l'emicrania, il tic dell'orologio diventa insopportabile - **Ipoestesia** → riduzione. Es: nella depressione, il cibo perde sapore

Distorsioni qualitative: - **Micropsia** → gli oggetti appaiono più piccoli del reale - **Macropsia** → gli oggetti appaiono più grandi del reale - **Dismegalopsia/galopsia** → oggetto deformato, asimmetrico - **Dissociazione delle percezioni** → incapacità di collegare stimoli di sensi diversi

False percezioni: - **Illusioni** → interpretazione erranea di uno stimolo reale presente. Non è necessariamente patologica. Tipi: - *Da completamento*: il cervello completa un'immagine incompleta (es. il triangolo di Kanizsa — zero triangoli disegnati, ma il cervello ne vede due) - *Affettive*: lo stato emotivo altera l'interpretazione (es. il bambino che vede una sagoma spaventosa nel buio — in realtà è il maglioncino appeso alla porta; la vedova che vede il marito nel cappotto a terra) - **Allucinazioni** → percezioni in assenza di oggetto. Non c'è nessuno stimolo

reale, ma la persona la vive come reale. Possono riguardare tutti i sensi. Verranno approfondite nella lezione sulle psicosi.

Agnosie → incapacità di riconoscere un oggetto pur avendo i sensi integri. Le informazioni arrivano correttamente al cervello, ma non vengono elaborate per riconoscere cosa sia. Tipi: - Visiva, uditiva, tattile, gustativa... - **Prosopagnosia**: incapacità di riconoscere volti familiari. Nelle demenze avanzate può arrivare a non riconoscere la propria immagine allo specchio (libro citato: *Ho scambiato mia moglie per un cappello* di Oliver Sacks) - **Anosognosia**: incapacità di riconoscere il proprio stato di malattia

3.6 Umore e disturbi dell'attività operativa

L'**umore** (con il suo "pendolo timico") rientra nella semiologia dello stato mentale attuale ma verrà trattato la settimana successiva — quattro ore dedicate.

I **disturbi dell'attività operativa** riguardano le funzioni di sintesi intellettuale: attenzione (già trattata), capacità di astrazione, corso del pensiero e disturbi del giudizio. Quest'ultimo — frequente in psichiatria, reversibile nelle situazioni confusionali, irreversibile nelle demenze — verrà ripreso nelle lezioni sulle psicosi.

4. Funzioni Cognitive e Neuropsicologia

Sezione curata da Fabiana Zanchi (fonte: Rossi & Stratta, 2006 e altri).

Le **funzioni cognitive** sono le operazioni mentali che permettono di raccogliere informazioni dall'ambiente, riconoscerle, immagazzinarle e usarle per agire nel mondo in modo adeguato. Sono strettamente legate alla qualità di vita.

Il cervello è un sistema di circa 100 miliardi di neuroni, organizzato in due emisferi (collegati dal corpo calloso) con quattro lobi: frontale, parietale, temporale, occipitale. Ciascuno specializzato ma fortemente interconnesso.

Principali funzioni cognitive:

Funzione	Cosa fa
Memoria	Apprende, trattiene e riattiva le informazioni
Attenzione	Seleziona e mantiene le risorse cognitive sul compito
Funzioni esecutive	Organizzano comportamenti complessi, problem solving, pianificazione, inibizione
Linguaggio	Sistema di segni per comunicare e comprendere la realtà
Funzioni gnosico-percettive	Riconoscimento delle informazioni dai canali sensoriali
Prassie	Movimenti pianificati e finalizzati
Emozioni	Reazioni complesse che mirano alla sopravvivenza e ai bisogni fondamentali

Principio chiave: **lo stesso comportamento può derivare da lesioni diverse**. Se un paziente non risponde, potrebbe avere un deficit attentivo, un disturbo della comprensione, un deficit di espressione o un problema di memoria. L'osservazione clinica attenta è fondamentale.

I **neurotrasmettitori** (dopamina, serotonina, noradrenalina, GABA, glutammato, acetilcolina, ecc.) sono le sostanze che permettono la comunicazione sinaptica tra neuroni. Molte malattie psichiatriche sono legate a livelli non fisiologici di alcuni di questi — ed è qui che entrano in gioco i farmaci.

5. Breve Introduzione alla Psicofarmacologia

Fin qui ci siamo? Bene — perché ora arriviamo alla parte che riguarda direttamente il lavoro dell'operatore sociale.

5.1 Breve storia

La psicofarmacologia moderna nasce convenzionalmente nel **1952** con la scoperta dell'effetto antipsicotico della **cloropromazina** (scoperta per caso, inizialmente usata come antistaminico). Poi: - **1957**: primo antidepressivo - **Anni '50**: scoperta delle benzodiazepine - **Anni '90**: antipsicotici atipici e Prozac

5.2 Definizione e meccanismi

Gli **psicofarmaci** sono sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale alterando l'umore o il comportamento (**Faravelli, 2010**). Si differenziano secondo: - **Farmacodinamica** → su quali recettori agisce il farmaco e in che modo - **Farmacocinetica** → come il farmaco entra in circolo, si trasforma e viene eliminato

Il parametro chiave per l'operatore sociale è l'**emivita**: il tempo necessario al corpo per ridurre del 50% la concentrazione del farmaco nel sangue.

L'emivita determina ogni quanto va somministrato il farmaco.

Somministrare troppo presto = sovraccarico. Troppo tardi = il paziente resta scoperto dalla terapia. Fondamentale anche per gestire il cambio di farmaco: bisogna aspettare un numero di emivite prima di introdurne uno nuovo, per evitare interferenze.

5.3 Pregiudizi da smontare

Il prefisso "psico-" genera paure. Non esistono "cardiofarmaci" o "epatofarmaci" — solo "farmaci per il cuore". Solo gli psicofarmaci hanno quel prefisso, e questo spesso fa pensare a qualcosa che "cambia la personalità" o che crea dipendenza.

Due posizioni ugualmente disfunzionali: 1. **Rifiuto totale** ("mi cambierà, creerà dipendenza") → non è una regola generale. Alcune classi possono dare dipendenza, non tutte 2. **Fiducia cieca** ("il farmaco risolve tutto") → agisce su alcuni sintomi, non è una soluzione magica. Stesso farmaco + stessa diagnosi = effetti diversi da persona a persona

Errore da evitare: dedurre la diagnosi dalla terapia. Il paracetamolo si prende per il mal di testa o per la febbre. Sapere che qualcuno lo prende non dice quale sia il problema. Stesso principio per gli psicofarmaci.

5.4 Classi principali

Antipsicotici - Prima classe scoperta (1952, cloropromazina) - **Agiscono sui sintomi positivi: deliri, allucinazioni, disturbi del linguaggio** - **Tipici** (prima generazione): più effetti collaterali (sindrome simil-parkinsoniana, iperprolattinemia) - **Atipici** (seconda generazione, anni '90): meno effetti collaterali extrapiramidali. Alcuni pazienti però rispondono meglio ai farmaci di prima generazione

Antidepressivi - Non solo per la depressione: anche ansia, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi alimentari psicogeni, controllo degli impulsi, sintomi negativi della schizofrenia - Sono **bifasici**: prima di sentire l'effetto passano 2-3 settimane - Rischio: il paziente interrompe la terapia perché non vede miglioramenti. Nelle prime settimane il rischio suicidario può aumentare → il paziente va informato e accompagnato

Ansiolitici - **Benzodiazepine**: effetto immediato sull'ansia, ma possibile dipendenza a lungo termine - **Strategia comune: benzodiazepine nella fase acuta + antidepressivo ad azione ritardata → poi scala progressiva delle benzo** - A seconda del dosaggio: effetto ansiolitico, sedativo, miorilassante o anticonvulsivante

Stabilizzatori dell'umore - Per il disturbo bipolare (mania e prevenzione delle ricadute) - **Sali di litio**: efficaci, ma tossici se sovradosati → richiedono controlli ematici regolari - Se interrotti bruscamente: alta probabilità di ricaduta entro 6 mesi

Principio generale: la terapia farmacologica è sempre integrata. Il farmaco è **una parte** della presa a carico del paziente, mai l'unica.

Domande di orientamento allo studio

Qual è la differenza tra segni e sintomi in semiologia psichiatrica? Fai un esempio per ciascuno.

I segni sono indicatori di malattia oggettivamente rilevabili dal curante dall'esterno — ad esempio un tremore, la frequenza cardiaca, o la mimica ridotta (amimia). I sintomi sono invece indicatori soggettivi riferiti dal paziente, come il mal di testa, la sensazione di angoscia o la mancanza di piacere. La distinzione è fondamentale perché cambia il punto di vista: il segno è ciò che osservo io; il sintomo è ciò che l'altro mi racconta di vivere.

Descrivi le principali alterazioni della coscienza dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Qual è clinicamente il più grave?

Le alterazioni quantitative seguono una scala progressiva: **lucidità → ottundimento → torpore → sopore → coma**. Il torpore è già clinicamente rilevante perché il paziente, se non stimolato, perde i sensi. Le alterazioni qualitative includono lo stato confusionale/delirium, la mania à potu, lo stato crepuscolare, lo stato oniroide, l'automatismo e lo stupore. **Il disorientamento nella persona (non sapere chi si è) è clinicamente il più grave, specialmente se associato a disorientamento in spazio e tempo — segnala una problematica cerebrale seria.**

Distingui illusione da allucinazione. Quando l'illusione non è patologica?

L'illusione è un'interpretazione erranea di uno stimolo reale presente: la realtà c'è, ma viene percepita in modo distorto. Può essere da completamento o affettiva. Non è necessariamente patologica. L'allucinazione invece è una percezione in assenza di oggetto: non c'è nessuno stimolo reale, ma la persona la vive come reale — può riguardare tutti i sensi.

Cos'è l'anosognosia e perché è rilevante clinicamente?

L'anosognosia è l'incapacità di riconoscere il proprio stato di malattia. **Non è negazione volontaria o meccanismo di difesa: è un deficit neurologico. La persona**

non sa di stare male. Per l'operatore sociale è fondamentale distinguerla dal diniego — la risposta relazionale e clinica è molto diversa.

Cosa deve sapere un operatore sociale sui principali farmaci psichiatrici? Quali sono i rischi chiave legati agli antidepressivi?

L'operatore sociale deve conoscere le classi principali: antipsicotici (agiscono sui sintomi positivi — deliri, allucinazioni), antidepressivi (usati anche per ansia, DOC, disturbi alimentari — non solo per la depressione), ansiolitici come le benzodiazepine (effetto immediato ma rischio di dipendenza), stabilizzatori dell'umore come i sali di litio (richiedono monitoraggio ematico regolare). Il rischio chiave degli antidepressivi è la bifasicità: passano 2-3 settimane prima che il paziente senta l'effetto, e nelle prime settimane il rischio suicidario può aumentare — il paziente va informato e accompagnato.

Concetti chiave

Termine	Significato
Semiologia	Studio dei segni rilevabili nel paziente per comprenderne lo stato
Segni	Indicatori oggettivi rilevabili dal curante (es. febbre, tremore)
Sintomi	Indicatori soggettivi riferiti dal paziente (es. dolore, angoscia)
Ipertimia	Mimica particolarmente espressiva
Amimia	Mimica assente o ridotta
Catatonìa	Perdita di iniziativa motoria con aumento del tono muscolare
Stereotipie	Schemi comportamentali ripetuti (es. dondolamento)
Fuga dissociativa	

Termine	Significato
	Allontanamento improvviso post-traumatico, con amnesia dell'episodio
Mania à potu	Stato maniacale da bassi quantitativi di alcol ($\neq$ delirium tremens)
Amnesia anterograda	Impossibilità di codificare nuove info dopo un evento indice
Amnesia retrograda	Impossibilità di recuperare info immagazzinate prima dell'evento indice
Confabulazioni	Falsificazioni involontarie della memoria in stato di lucidità
Illusione	Interpretazione erronea di uno stimolo reale
Allucinazione	Percezione in assenza di oggetto
Agnosia	Incapacità di riconoscere un oggetto pur avendo i sensi integri
Prosopagnosia	Agnosia specifica per i volti
Anosognosia	Incapacità di riconoscere il proprio stato di malattia
Emivita	Tempo per ridurre del 50% il farmaco nel sangue
Farmacocinetica	Come il farmaco entra, si trasforma e viene eliminato
Farmacodinamica	Come e su quali recettori il farmaco agisce

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** "normalità personale" (lezione 01) — sempre come punto di riferimento per valutare i cambiamenti nel paziente; meccanismi di difesa (lezione precedente)
- **Lezioni successive:** umore e disturbo bipolare (lezione 06, 4 ore); psicosi e allucinazioni; disturbi alimentari; sessualità; farmacologia approfondita

- **Temi aperti:** disturbo del giudizio (rimandato alla lezione sulle psicosi), corso del pensiero

Fonti principali: Pewzner (2002), Sims (2009), Baddeley et al. (2011), Valler & Papagno (2011), Feldmann et al. (2017), Faravelli (2010), Stahl (2016), Rossi & Stratta (2006)